EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90626
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-14 11:58:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ANGEL RETAMAL ZU◆IGA			**RUN**	: 12.132.808-9
F.Nac	: 13-04-1969	**Edad**	: 55 AÑOS, 4 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: COLVINDO HERMANA: 982638272			**Comuna**	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 984555310		
Fecha Ingreso	: 2024-07-31	**Fecha Egreso**	: 2024-08-14 11:58:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: DOMICILIO	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico lenticular y corona radiada izquierdos, trombolizado (27/7/24) y trombectomizado (TICI 0), c/TH PH-1 (c/HSA cortical + extravasación de contraste yodado)
-Oclusión M1 izquierda no recanalizada
-Neumonía posterobasal derecha 2° a S pneumoniae resuelta, ATB 7/7
-Déficit B12
-Anemia moderada ferropénica
-Hipotiroidismo subclínico
-Ant: ACV antiguo fronto-insular izquierdo - Discapacidad intelectual mRS 2-3

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

BEG, HDN estable, afebril, sin requerimiento de O2, tranquilo, impresiona sin dolor y más reactivo, tolera bien alimentación por SNG y VO, tos productiva ocasional, moviliza adecuadamente las secreciones bronquiales, mejor control de tronco, logra bipedestación con 1 operador.
Completó tt ATB por neumonía.
Pendiente ETT y Holter de ritmo. Colonoscopía no mostró lesiones tumorales. TC TAP describe enfermedad bronquial crónica, focos de parénquima atelectásico en lóbulo inferior derecho probablemnete por neumonía en remisión, engrosamiento parietal estratificado del recto y sigmoides distal inespecífico impresiona inflamatorio o podría estar relacionado al uso de enemas, dilatación colónica proximal sin engrosamientos parietales sospechosos asociados.
EDA decribe gastropatía congestiva antral de aspecto parcelar y superficial, test ureasa negativo, biopsia tomada.
Diuresis(+), dep(+)
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio hoy para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica, y control ambulatorio en policlínico de Neurología para definir continuar estudio ambulatorio con exs pendientes (ETT y Holter ritmo).

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica
-Control en policlínico de Neurología en 10-15 días
-TC cerebro s/c hoy

INDICACIONES AL ALTA

1. -Clopidogrel 75 mg/día
2. -Atorvastatina 40 mg 2 comp/noche
3. -Famotidina 40 mg/día
4. -Losartan 50 mg c/12 horas
5. -Amlodipino 10 mg/día
6. -Hierro 1 comp/día

OBSERVACIONES:

Ex fco gral:
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T no ausculto soplos
-Pulmonar: MP(+), SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos +/+

Ex neurológico:
-Mental: vigil, emite lenguaje lenguaje muy escaso, sigue órdenes simples intermitentemente, resto no evaluable
-PC: CV por amenaza impresiona hemianopsia derecha, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC derecha leve, nistagmo(-), úvula y lengua centrales, resto n/e
-Motor: BC izq M5, BC der M1-2 (mejor a crural), RCP extensor derecho
-Sensibilidad: algesia impresiona conservada en las 4 EE y fascie
-Cerebelo: n/e
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO